

聽見聲音的轉變， 跟著痛苦走， 在標記處進入任務

督導的歷程：同盟、人際技能、
個案概念化與介入技能

依據 Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. APA. (第3章，pp. 45–79)

碩士層級臨床心理學教材 | 督導示例摘述自原書（原書已改寫以保密）

讀完這份資訊圖，你能夠……

1. 區分五種同理回應，並最多領先一步
2. 追隨痛苦羅盤，暫定核心自我組織
3. 辨認四種聲音品質與生產性七向度
4. 把個案語句對應到七種任務標記
5. 指出雙椅、空椅中偏離結構之處
6. 區分情性知識與程序性知識
7. 隨新資料更新一個持續個案的概念化
8. 說明同盟如何影響回饋的接受度

督導歷程的三大焦點

① 督導同盟

督導開始或失敗的地方

② 受督者的人際技能

同盟形成、在場、核心條件：無條件正向關懷、真誠、同理

③ 受督者的技術技能

個案概念化與介入技能

為什麼是全書核心

這一章幾乎就是 EFT 臨床能力的完整清單。

同盟是第一個督導任務

「先接觸，再訂契約」

Gendlin & Beebe (1968)

督導者需要與受督者建立溫暖、同理、驗證的連結；督導者必須在場、活在當下，並回應受督者的感受與需要。

在這個基礎上
才能建立對督導目標與任務的合作。

督導同盟的三個成分

(a) 強烈的情感連結

關係的溫暖與依附

(b) 對目標的共識

例：熟練特定技能、擴展概念化能力

(c) 任務被認為有關聯

例：用同理探索或角色扮演，而不是講授，來處理某個議題

一句話

把關係的溫暖與合作的工作結合起來（Bordin, 1983）。

同盟是共構的， 但督導者負主要責任

同盟是整個督導歷程的基礎：辨識標記、任務環境、受督者的改變與解決。

受好評的督導者特質 (Falender & Shafranske, 2004)

同理、不評判、驗證與肯定、接納、鼓勵探索與嘗試、正直、給予自主、體諒

支持連結的個人特質 (Geller & Greenberg, 2011)

在場、真誠、溫暖、同理，以及情緒投入的能力

有了好的同盟， 回饋才不會令人羞恥

安全基地

受督者有安全感，敢嘗試、敢犯錯

穩定的基礎

督導者能提出更同理的替代回應

同盟好，受督者較能接受回饋，也較不會覺得建設性批評具有威脅性或令人羞恥。

臨床上要問什麼？

受督者對回饋出現防衛或順從時，先檢查同盟，而不是加重回饋。

目標共識，本身就是同理

取得目標與任務的共識，取決於理解個案，以及什麼對他有幫助。

✗ 行為改變目標

「減少和先生吵架的次數」

✓ EFT 的目標共識

捕捉個案長期掙扎的痛苦，同意一起處理這份痛苦

督導者的角色

引導受督者取得對主要目標的共識。

關係的技能與存在的技能

關係的技能

與個案形成並維持強的治療同盟

存在的技能

在場並同理：活在當下、調頻情感、傳達同理、敏感地回應

營造溫暖、驗證的氛圍，邀請個案探索自己，並合作處理目標與任務。

基礎

知覺技能是回應與調頻的基礎；在場是知覺此時此地的前提。

治療性在場

把整個自己帶進與個案的相遇，在多個層次上完全處在當下：

身體

情緒

認知

靈性

完全沉浸於當下，不帶評判或預期，與個案同在，也為個案而在。

地位

在場是調頻與回應的前提（Geller & Greenberg, 2011）。督導者持續協助受督者看見非語言訊息，並加以回應。

在場怎麼練起來？

觀察與傾聽逐刻歷程



協助個案符號化



反思與新理解

目標：高度的同理調頻

隨時調頻於個案敘事中的細微差異與隱含意義，也調頻於當下的治療關係。

要能整合

情緒與理性、過去與現在、需求與價值

同理探索是基礎任務

Greenberg & Elliott (1997)

類型	主要功能
同理理解	傳達並核對理解；提供安全
同理肯定	肯定並確認經驗
喚起性回應	讓經驗鮮活
探索性回應	聚焦前緣，使內隱變外顯
同理臆測	治療師的猜測；適合理智化的個案

後三種合稱「探索性同理」。

同理理解：提煉精髓

它是基礎任務：傳達對個案經驗的理解，並核對理解。

督導者反覆指出

同理理解是提煉並傳達個案溝通的精髓。

它不是要推動探索，也不是要提高喚起。

它在做的是

跟隨個案的敘事、保持在場與回應、傳達理解。

探索性回應：走到前緣

EFT 督導中同理介入的基本模式：聚焦於個案經驗的前緣，使內隱變成外顯。

關鍵技巧

回應以個案陳述中最鮮活的地方收尾，個案的注意力就會聚焦在那裡，進而分化經驗的前緣。

臨床上要問什麼？

他剛才說的話裡，哪一個字最有溫度？我的回應有沒有停在那裡？

同理臆測：從我的架構猜測

探索性回應

停留在個案的參照架構內

同理臆測

明確來自治療師的參照架構：
猜測，或建議個案試說的語句

「我想像你感覺……」

「我的預感是……」

何時特別有用

讓理智化的個案停留在感受上。

「毛骨悚然」是前緣

個案在空椅中面對母親，說出好幾種感受：難過、「我愛你」，也說母親有些地方讓他覺得毛骨悚然。

督導者的重點

對偏理性的他來說，說出了很多感受。「我愛你」時可以放大（「再說一次」）；但現在出現了「毛骨悚然」，這是很強的字眼，值得反映並探索。

教學要點

辨識前緣，反映最觸動之處，把注意力引向內在。

個案沒說， 但治療師「感覺進去」了

治療師臆測：「好像有另一份感覺，害怕如果離開，這可能是唯一的機會？」

個案：「對，我真的這樣覺得。」

督導者的肯定

很好的同理臆測。她沒有說出來，但你感覺進去，抓到了精髓：「我很害怕。」

教學要點

好的臆測會被個案確認，並把經驗帶得更深。

手指在敲：他被活化了

個案聽到母親希望他當好孩子，只說：「聽到這個會很有意思。」同時手指在敲打。

督導者：歷程上「危險」

「有意思」停留在外面；敲打顯示他開始激動、被活化。我們要知道他內在實際發生了什麼。

治療師：「你看起來其實有點難過。」

督導者：很好，你在轉向情感軌道；用臆測或觀察，把他的注意力帶向內在。

把他「留住」

個案：那些期待與限制窄化了他本來可能成為的人。

治療師：「停留在那個感覺。」

督導者的肯定

他進入猶豫的處理方式，聲音變得更聚焦、更內在。我原本擔心他會跳出去解釋，但你把他留住了。「窄化」是一種體會到的意義。

治療師：「在身體哪裡？是什麼質地？」

個案深吸一口氣，指向太陽神經叢。

「被剝奪」：關鍵時刻

個案：「我覺得……被剝奪了……但我覺得……」，開始轉向意義敘事。

督導者：這是核心

要引導，幾乎打斷地說：「就是被剝奪。」

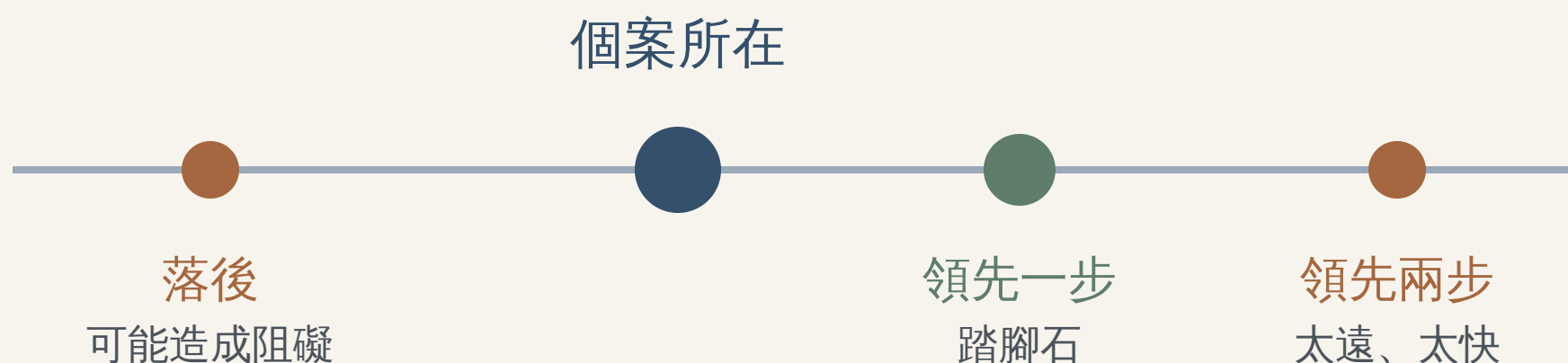
對理智型處理者：用臆測展開內在

「就是被剝奪……有好多你需要、想表達的自己……像被從膝蓋砍斷。」

督導者的結語

你做得很好，只是可以更貼近。

最多領先一步



同理回應要聚焦於正在浮現或隱含的成長可能性，但保持在個案的近側發展區：個案伸手可及之處。

探索性同理， 要與同理理解平衡

同理理解

帶來被理解的感覺，提供安全、接納與驗證的框架

探索性同理

把經驗帶向前緣，產生新的意義

容易誤解

越深的回應不一定越好。只有探索、沒有理解，個案會覺得被推著走。

有紀律的接納與一致

督導者在看錄影時討論，並示範回應。

正向關懷

接納個案的所有經驗；傳達珍視的態度：重視個案，不帶評判地接納。

真誠

個案與治療師之間真誠的關係，以及它的恆定性，提供矯正性情緒經驗。真誠是處理關係議題的關鍵（見單元4）。

概念化從情緒痛苦開始

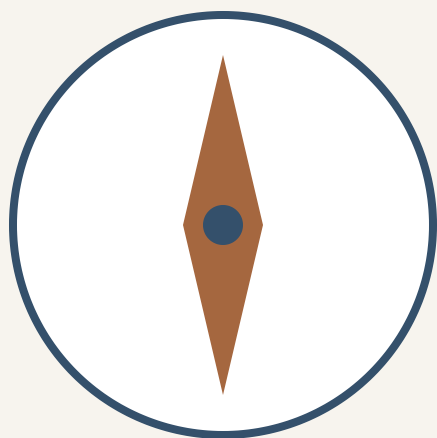
安全的關係形成、敘事展開之後，督導者引導受督者聽見：

- 個案如何處理情緒、建構意義
- 個案的處理風格如何促進或阻礙他取用內在經驗

首先聚焦

個案的情緒痛苦（Goldman & Greenberg, 2015）。個案表達痛苦的方式，以及他對治療師回應的反應，引導介入。

跟著痛苦羅盤走



個案表達痛苦的方式

→ 追隨它

→ 抵達核心困難

在追隨痛苦並抵達之前，
我們無法說出核心是什麼。

原書督導示例語句，改寫整理

不是先畫一張人格地圖

✗ EFT 督導不鼓勵先描繪

持久的人格、性格動力、防衛、核心信念、跨時間重複的關係模式

✓ 而是鼓勵

追隨個案的痛苦，讓痛苦作為羅盤，引導抵達核心困難

批判提醒（延伸）

在跨專業場域，可能仍需要其他概念化形式；兩者可以並行，但用途不同。

核心情緒自我組織

以痛苦的、原發的、非適應性的情緒基模為基礎，是個案最穩定、最持久的問題自我狀態。

依據什麼辨識？

個案的現象學經驗，而不是對假設性潛在原因的詮釋或推論。

怎麼抵達？

對情感的同理調頻，讓個案感到安全、被驗證，並帶領雙方抵達核心的痛苦擔憂。

三種典型的核⼼組織

焦慮不安全

核⼼上基本不安全，源於核⼼的焦慮；無法獨處

悲傷的孤單被遺棄

伴隨遺棄恐懼的核⼼悲傷

羞愧

基於核⼼羞愧而覺得不足、沒有價值

也可能是這些的特殊組合。

核心組織幫我們做什麼？

組織資訊

引導治療的方向

形成敘事

核心感受如何影響經驗、行為、思考與關係；是合作的歷程

原書示例（配套 DVD）

督導者問：「核心的情緒基模，或核心傷口是什麼？」雙方協助個案抵達：「如果我做自己，我就不會被接受。」這是以羞愧為基礎的核心組織。

標記也是通往核心的路

自我批評、對重要他人的未解決感受。

階段一：展開敘事， 觀察處理風格

通常在前三次晤談

- 1 同理回應，促進個案描述主訴（症狀、行為、關係）
- 2 傾聽鮮明與痛苦之處；督導者指出語言與非語言訊號
- 3 觀察個案的情緒處理風格
- 4 促進生命故事展開（與認同、依附有關）

階段二：追隨痛苦， 共同建構焦點

5 辨識任務標記：適合特定介入的機會

6 辨識核心情緒基模（適應性或非適應性）

7 辨識情緒中蘊含的需求

8 辨識遮蔽原發情緒的次發情緒

階段二（續）

9 辨識通往核心情緒的阻礙

10 共同建構主題：如何對待自己、如何對待他人、如何被對待；有時還有存在主題（失落、死亡、界線、選擇）

11 共同建構敘事：把主訴連結到核心情緒基模

整體方向

從在關係中解構主訴，走向辨識核心基模與自我組織。

什麼時候做什麼？

歷程	時機
評估處理風格、展開敘事	治療關係的開始
傾聽鮮明與痛苦	早期就開始，貫穿全程
命名核心情緒	安全同盟建立之後
整合主題、理由與焦點	較後期；短期治療（12–20 次）約第 4 次

何時提供敘事？

需要理由與焦點來強化合作時：個案詢問、感到困惑，或需要更清楚。

介入技能督導的三個面向

① 理論理解

對改變歷程的理解；督導者引介介入理論與研究，以及背景閱讀

② 敏銳的知覺技能

看見正在發生什麼

③ 逐步建立治療任務

在標記出現時進入任務

懂，但用不出來？

惰性知識

智識上知道，需要時卻用不出來（Greenberg & Safran, 1986）

程序性知識

在具體情境中表現出來的理論
理解：親身認識的知識

督導在建立「主動的知道如何做」。

治療師透過觀察、傾聽，並同理地回應個案而發展。

知覺技能

看見正在發生什麼，並把它解讀為適合某種介入的機會。

怎麼學得最多？

取用並標記（符號化）一位真實個案的經驗，然後在每次晤談中，以合作、平等的方式找出這些經驗的意義。

看、聽、同理的技能

察覺非語言的瞬間變化；理解個案如何經驗事件；辨識個案的微歷程。

三類歷程標記

Goldman & Greenberg (2015)

逐刻微標記

語言：細微差異、鮮明度、漫談；具體、特定、生動與否

非語言：猶豫、不一致的情感、聲音、喚起或經驗程度、痛苦

特徵風格標記

自我批評、自我保護，還是自我貶抑？他人是遺棄的、迫害的，還是支持的？

主要任務標記

顯示個案準備好處理某個議題

逐刻判斷個案如何處理情緒

聲音品質

注意力與能量如何部署

經驗程度

經驗的深度

情緒喚起

強度與受限程度

情緒生產性

是否以接觸性覺察的方式處理

同時也要區分

原發適應性、原發非適應性、次發、工具性情緒（見單元 1）。

四種聲音品質

Rice & Kerr (1986) ； Rice & Wagstaff (1967) | 督導者在錄影中指出音高、能量、節奏與重音

聚焦型

轉向內在、追蹤經驗

外化型

像演講、「對著說」

受限型

尖細、戒備、被勒住

情緒型

情緒突破而出

聚焦型 vs. 外化型

聚焦型

個案轉向內在，追蹤經驗，試著把它符號化成語言。

(延伸) 常是深化經驗的好時機。

外化型

平穩、有節奏，能量向外；預先排練過、像演講，缺乏自發性。可能很有表現力，卻有「對著說」的感覺；內容不太可能是新鮮經驗到的。

受限型 vs. 情緒型

受限型

不在正常音域，常顯得尖細；聲音背後有戒備，顯示情感被勒住，或許難以信任。

(延伸) 先注意安全感與同盟。

情緒型

說話時，情緒突破而出進入聲音。

(延伸) 情緒正在發生，需要調頻與涵容。

經驗量表：培養敏感度， 不是當場評分

它是研究工具

治療師坐在個案面前時不即時編碼，因為那會干擾在場與逐刻調頻。治療師是受到對量表的理解所引導，這種理解來自在其他示例與自己的錄影上練習。

個案持續處在低經驗程度時

提供更深的探索性反映與臆測，並觀察個案轉向：

內在：「我覺得心裡好亂」

外在：「我不知道他什麼時候回家」

情緒喚起：中等 vs. 最高

Warwar & Greenberg (2000) | 依聲音與身體的喚起，以及表達受限的程度評估
| 先判斷是否為原發情緒，再評估強度

中等程度

聲音與身體中度喚起；出現情緒型聲音；說話模式被情緒溢出中度打斷（重音、速度、音高改變）；仍有些受限

最高程度

強烈而完整；說話模式被完全打斷；看起來無法控制、持續；有「崩解」的質地

不是越強越好

研究 (Missirlian 等, 2005)

中等程度的情緒喚起結合意義建構，而不是單純的高度喚起，可預測經驗性治療的正向結果。

相關性研究，不宜直接推論因果。

另一個警訊

個案談論重大、有意義的事件，卻沒有情緒喚起時，表示需要探索身體感受到的經驗。

情緒被喚起之後： 有沒有「生產性」？

Auszra & Greenberg (2008) ; Auszra, Greenberg, & Herrmann (2013)

一旦判斷是原發情緒，接著判斷：它是否以接觸性覺察的方式被處理？

這部分依據經驗、喚起與聲音的評估，但也需要對情緒表達本質的更高層次判斷。

怎麼學？

個別或在團體中編碼錄影，直到熟練。

情緒生產性的七個向度

1 注意：注意力在情緒上

2 符號化：說成語言

3 一致性：表達與經驗一致

4 接納：不抗拒情緒

5 調節：喚起可運作

6 主體性（vs. 被動受害）

7 分化（vs. 卡住）

七項都達成，才算有生產性地處理

各向度說明為本教材整理。

標記是地圖的入口

研究顯示，個案會進入可辨識的問題情緒處理狀態，這些狀態標示出底層的情感問題，並提供特定有效介入的機會（Greenberg 等, 1993；Rice & Greenberg, 1984）。

標記告訴我們

要用哪一種介入，以及個案目前的準備度

任務模型

解決路徑的關鍵成分已被界定，是引導介入的地圖

怎麼教

講解、觀察錄影、練習。

七種主要標記與介入

標記	介入
① 困惑反應	系統性喚起展開
② 不清楚的體感	澄心聚焦
③ 衝突分裂	雙椅演出
④ 自我中斷分裂	雙椅演出（中斷）
⑤ 未竟事務	空椅對話
⑥ 脆弱	同理肯定的驗證
⑦ 情緒痛苦與煎熬	慈悲的自我安撫

困惑反應 → 系統性喚起展開

標記

對自己在特定情境中的情緒或行為反應感到困惑。

「來的路上看到一隻耳朵長長下垂的小狗，突然好難過，不知道為什麼。」

介入

生動喚起經驗、重新經驗情境與反應，建立情境、想法與情緒反應之間的連結，抵達讓反應變得合理的隱含意義。

解決

對自我功能的新看見

不清楚的體感 → 澄心聚焦

標記

停在表面，或困惑、無法清楚感覺自己的經驗。

「我就是有種感覺，但不知道是什麼。」

介入 (Gendlin, 1996)

引導個案以注意、好奇與願意經驗的態度，接近經驗的身體面向，並為身體感受找到字詞。

解決

身體感受的轉變，以及新意義的創造

衝突分裂 → 雙椅演出

標記

自我的一個面向對另一個面向批評或強迫。

例：在姊妹眼中失敗後，很快感到無望、挫敗，也生氣：「我覺得比她們差，我失敗了。」

介入

讓兩部分直接接觸；探索並傳達各自的想法、感受與需求，進行真正的對話。

解決

批評的聲音軟化，兩邊整合

自我中斷分裂 → 雙椅演出

標記

「我感覺得到眼淚要上來，但我就是繃緊、吞回去，絕不要哭。」

介入：讓中斷變明確，並演出它

身體上：勒住、關掉聲音

隱喻上：關進籠子

語言上：「閉嘴、不要感覺、你撐不過去」

解決

經驗到自己是關閉歷程中的能動者 → 挑戰中斷的部分 → 表達被阻擋的經驗

未竟事務 → 空椅對話

標記

以高度投入的方式，陳述對重要他人揮之不去的未解決感受。
「我父親從來不在我身邊。我從沒原諒他。」

介入

活化內心的重要他人形象，經驗並探索自己對他的情緒反應，並理解它們。

解決

對他人與自我的看法轉變；追究對方的責任，或理解、原諒對方

脆弱 → 同理肯定的驗證

標記

自我感到脆弱、耗竭、深深羞愧或不安全。
「我覺得我什麼都沒有了。我完了。」

介入

最需要治療師的同理調頻：不只捕捉內容，還要注意生命力情感，映照節奏、韻律與語調；驗證並正常化。

解決

自我感增強

煎熬 → 慈悲的自我安撫

標記

通常發生在強烈的人際需求（例如愛或驗證）未被滿足時。

介入

想像地重回被剝奪的場景，讓成年的自己進入場景，給予過去沒有的撫慰；或問：「作為大人，你能安撫受傷的孩子嗎？」

解決

喚起對自己的慈悲。自我慈悲也會從調頻的治療師身上內化而來，但可能需要多年；這個介入可以加快歷程。

任務督導在處理什麼？

整個任務

任務中的某一步

流暢融合多個任務

在錄影中辨識出標記後，雙方一起釐清最適合的介入。

原書示例（配套 DVD）

督導者引導受督者請個案演出母親：「那你真的當一次你媽媽。她怎麼讓你覺得她很需要人？是她臉上的表情嗎？」之後督導者指出，個案演出母親說「我希望你當個乖孩子」時，聲音改變了。

「你失去椅子了」

督導者指出的問題

對話變成一場討論：在探索、分化衝突的各個面向，卻沒有表達批評來引發另一張椅子的情緒反應，失去處理分裂的力量。

修正

重新建立兩邊的接觸；讓這張椅子對另一張說：「沒希望了，結束吧，離開。」讓衝突更尖銳，看看是否會轉化。

決策衝突：先分清兩個聲音

28 歲女性，猶豫是否換到國外的新工作（原書示例摘述）

治療師只是複述：「一方面好、一方面壞，很複雜」

督導者：你抓到了分裂，但要更分化。兩個聲音各是什麼？（受督者：一邊說「去」，一邊說「我不太願意」）

個案開始用警告的聲音說話：「你會累的」

督導者：很好，支持這個聲音。

目標不是肯定， 是觸及核心痛苦

個案回嘴：「別煩我，你很煩」

支持她的肯定，但此刻的目標是觸及她核心的痛苦情緒：焦慮不安全。先問：「你身體感覺到什麼？」

她彈手指，說「應該這樣」

跟隨她的線索：請她換椅子，扮演驅策的那一邊。

她反覆說「怎麼辦、怎麼辦」

讓她更多地施壓，再回到經驗的椅子，問她感受到什麼。可以加一句：「給她壓力。」

扮演「負面的他人」

24 歲學生，童年重要的阿姨也拒絕了她（原書示例摘述）

✗ 開放式提問

「身為阿姨，你聽到這些有什麼反應？」→ 個案扮演的阿姨開始辯護。

✓ 具體的指令

「身為阿姨，讓她覺得被不公平對待。對她不公平！」目的是喚起痛苦的記憶與情緒。

受督者的回應

「我記得訓練時講過，但很難做到。」督導者：「但很重要，你要用它來激發感受。」

看似平靜，其實在保護

個案：「我覺得這只是一種防衛。」

督導者：這是自我中斷，可以用雙椅處理。

個案：「我覺得平靜，像是我在處理這個情況。」

督導者：這是保護性的歷程，保護她不去碰悲傷與憤怒。這是一個
選擇點：看似調節，其實是為了逃避而調節。

可以說：「我們換一下。你過來這裡。我們把阿姨請出椅子，現在這是你的一部分。」

督導結尾：確認概念化

核心的非適應性感受

孤單被遺棄

可能的解決路徑

她需要哀悼她希望擁有的阿姨，放下未被滿足的需求。先哀悼，再自我安撫，或表達肯定性（而非防衛性）的憤怒。

轉化

把孤單與遺棄重組為：對現在家庭的愛，以及對過去曾得到的愛的珍惜。

從哲學，回到眼淚

53 歲女性，伴侶多年前因意外過世（原書示例摘述）

治療中的時刻	督導者的重點
「讓情緒在這裡。」	很好，保持聚焦在她的情緒
她轉向「強加給自己的行動模式」	把她帶回想哭的傾向，取得情緒的訊息
她談人生很沉重的故事	太抽象了。她核心的感受與需要是什麼？
問伴侶的名字	很好，移向具體
「不知道是悲傷還是遺憾」	很好，更清楚地聚焦情緒

焦慮的 26 歲女大學生

原書連續督導示例摘述 | 每次督導：簡述晤談 → 想處理的議題 → 希望聚焦什麼

第 2 次：辨識標記

她經驗他人是評判的，因而焦慮、腦中空白，事後氣自己。督導者以提問教學：「你聽到標記了嗎？」→ 焦慮分裂：一部分災難化並嚇唬另一部分。

建議

先請她在批評的椅子上演出評判的「他人」，通常最有喚起性。

第 3 次

批評者很嚴厲，她覺得渺小、軟弱，也為困在循環中感到悲傷。下一步：讓批評更分化、更具體。

要演出，不要洞察

批評者說：「我先貶低你，別人就不會。」

督導者：這偏向洞察，而不是演出。讓批評者具體地演出：「昨天上課你問旁邊的人作業是什麼，結結巴巴，出盡洋相。」

核心還不確定

不被愛：是羞愧（「我有缺陷」），還是孤單被遺棄（「我無法獨自存活」）？

混合式臆測，保持開放

「好像又難過、又孤單，也害怕自己本來的樣子不被接受……好像從來沒有人真正愛你、重視你。」需求：驗證與親近。

焦點轉向與父親的未竟事務

第 4 次揭露的背景（摘要）

獨生女；父親情緒起伏大，曾讓她非常害怕，並有情緒虐待；母親忽視這些；她覺得自己不被想要。

第 5 次：空椅對話

她經驗並表達對父親的悲傷、孤立與孤單，自由地哭泣。督導者注意到一個小轉變：她以更內在聚焦的聲音說「對他來說已經太遲了」。

倫理提醒（延伸）

涉及虐待揭露時，同時留意目前的安全、法定通報義務，以及深化前的穩定度。

從「你是壞爸爸」 到「我很生氣」

✗ 拒斥性憤怒

說教的聲音：「你是個壞爸爸，太自私、太懦弱。」

✓ 賦能的憤怒

「我對你很生氣。」「我很憤怒你這樣做。」

在一定程度的外向憤怒之後，引導她使用「我」語言，把注意力放回自己的感受。

她懷疑自己有權生氣、有權快樂

督導者：這是自我中斷的標記，可以用自我中斷的雙椅處理，觸及被阻擋的憤怒與快樂的權利。

本章的整合模型

層次	督導者協助受督者……	關鍵工具
關係	建立並維持同盟	Bordin 三成分；先接觸
存在	在場、同理調頻	五種同理；領先一步
知覺	聽見、看見、判斷	聲音 4 型；量表；生產性 7 向度
概念化	追隨痛苦抵達核心	痛苦羅盤；11 步驟
介入	在標記處進入任務	7 種標記；守住結構

同時運作

「現在可以做空椅嗎？」需要同盟、準備度、概念化與技術，四者一起判斷。

懂，不等於會

「智識上知道、需要時卻用不出來的知識，就是惰性知識。」

“Knowledge in which one knows something intellectually but cannot use it when needed is inert knowledge”

臨床意義

臨床能力是程序性的：在此刻、對這位個案。

教學重點

在具體片段中被指出、練習、再嘗試。

痛苦是羅盤

「個案的痛苦就像一個羅盤，
它會帶你到核心所在。」

“The [client’s] pain is like a compass and it’ll lead you to whatever is [at the] core.”

臨床意義

概念化從跟隨出發，而不是從
推論出發。

教學重點

在錄影中找出最觸動的時刻。

同盟是必要條件

「督導者與受督者之間良好的督導同盟，是督導的必要條件。」

“A good supervisory alliance between the supervisor and supervisee is the sine qua non of supervision.”

臨床意義

技術只有在安全的關係中才能發揮作用。

教學重點

督導中感到不安全，本身就是需要處理的議題。

七個常見誤解

常見理解	更精確的理解
越深的同理越好	最多領先一步；要與同理理解平衡
情緒越強越有效	中等喚起 + 意義建構
初談後就要完成概念化	追隨痛苦，同盟穩固後才命名核心
看到標記就做任務	標記也代表準備度
平靜 = 調節得好	可能是為了逃避而調節
憤怒就要強化	先轉為「我」語言的賦能憤怒
量表要在晤談中評分	用來培養敏感度，不即時評分

「我請個案扮演媽媽，問她媽媽會怎麼說。」

✗ 錯在哪裡

開放式提問常引出對方想像中的辯護，對話變成母女辯論，而不是喚起個案的痛苦經驗。

✓ 修正

對話早期：「過來這裡，當那個讓你覺得被忽視的媽媽。」先喚起負面經驗，等個案觸及原發感受與需求之後，再問對方如何回應。

第 5 章會再深入

換椅子的時機與空椅的微技巧（見單元 5）。

檢查一下你記住了什麼

Q1 個案語調平穩、有節奏，像在講一段講過很多次的故事。這是哪一種聲音品質？

Q2 「我感覺得到眼淚要上來，但我就是吞回去。」這是哪一種標記？用什麼介入？

Q3 同理臆測和探索性回應，最主要的差別是什麼？

Q4 概念化時，什麼時候才適合命名核心情緒？

解答與一句話說明

A1 外化型。預先排練、「對著說」，內容不太可能是新鮮經驗到的。

A2 自我中斷分裂 → 雙椅演出。讓個案演出自己如何中斷，經驗到自己是能動者。

A3 參照架構。臆測明確來自治療師的架構；探索性回應停留在個案的架構內。

A4 安全的同盟建立之後。短期治療中，焦點大約在第 4 次晤談形成。

此刻該怎麼回應？八個步驟

1 話語與聲音品質

2 是原發嗎？準備好了嗎？

3 經驗、生產性、標記

4 調節，還是逃避？

5 用一句回應測試

6 理解、探索、臆測、任務

7 看個案的反應

8 領先一步；守住結構

追隨痛苦羅盤的問題清單

問題	步驟
主訴是什麼？哪裡最觸動、最痛？	1–2
怎麼處理情緒？故事如何展開？	3–4
有哪些標記？核心基模是什麼？	5–6
需求是什麼？哪些次發情緒在遮蔽？	7–8
什麼阻礙了觸及核心？	9
主題與敘事是什麼？	10–11

不確定時
用混合式臆測，讓個案的反應告訴你答案。

標記 → 準備度 → 介入 → 結構

1 這是哪一種標記？

2 準備好了嗎？（同盟、穩定度、經驗程度、時間）

3 介入是什麼？解決長什麼樣子？

4 結構還在嗎？（兩邊有接觸？先扮演負面他人？）

5 出現新標記了嗎？（例如空椅中出現自我中斷）

這對實務意味著什麼？

面向	本單元的意涵
評估	聲音、經驗、喚起、生產性；三類標記
概念化	追隨痛苦；以現象學為依據；同盟穩固後才命名
計畫	標記引導任務，也代表準備度
關係	目標共識 = 捕捉長期痛苦
介入	依時機選同理類型；守住任務結構
督導	錄影逐刻教學；以提問教學；練習編碼

哪些主張有證據？

主張	證據性質
標記代表問題狀態與準備度	任務分析的歷程研究
中等喚起 + 意義建構	Missirlian 等（2005），相關性研究
情緒生產性七向度	Auszra 等（2013）的評估架構
在場是調頻的前提	Geller & Greenberg（2011）理論整合
受好評的督導者特質	Falender & Shafranske（2004）整理
督導示例	真實錄影的示範，不是效果證據

還沒有答案的問題

1. 「不描繪人格與防衛」的概念化，在跨專業溝通中夠用嗎？
2. 聲音與喚起的表現有文化與個人差異，怎麼避免誤判？
3. 相關性研究能支持「應該追求中等喚起」的臨床建議到什麼程度？
4. 深化創傷記憶前，怎麼判斷個案夠穩定？
5. 「扮演負面他人」在什麼情況下可能造成傷害？

四個層次的學習

必須記住

同盟 3 成分；同理 5 型；核心組織 3 種；11 步驟；標記 3 類；聲音 4 型；生產性 7 向度；任務 7 種

必須理解

在場是前提；最多領先一步；痛苦羅盤；情性知識；標記代表準備度

必須能夠應用

選擇同理類型；辨識聲音與標記；守住結構；轉為「我」語言

必須能夠質疑

相關性研究的限度；文化差異；示例不等於證據

在抵達之前， 我們無法說出核心是什麼。

主要來源：Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. Washington, DC: American Psychological Association. 第3章 (pp. 45–79)。

原書引用：Bordin (1983)；Gendlin & Beebe (1968)；Falender & Shafranske (2004)；Geller & Greenberg (2011)；Greenberg & Elliott (1997)；Goldman & Greenberg (2015)；Greenberg & Safran (1986)；Rice & Kerr (1986)；Warwar & Greenberg (2000)；Missirlian et al. (2005)；Auszra et al. (2013)；Greenberg, Rice, & Elliott (1993)；Gendlin (1996)。

督導示例為原書內容的摘述，原書已改寫以保密。下一單元：同盟與人際技能的常見督導議題 (第4章)